

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE LAWTON Y BRODY (AIVD)

Eje IV: Funcionamiento y Autonomía • Evaluación de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria en Adultos Mayores

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Actividades Instrumentales de la Vida Diaria de Lawton y Brody (Escala de Lawton).
Nombre Original	Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL; Lawton & Brody, 1969).
Autores Originales	M. Powell Lawton, Ph.D. y Elaine M. Brody, M.S.W. (Philadelphia Geriatric Center, EE.UU.).
Adaptación Hispana	Cid-Ruzafa y Damián-Moreno (1997); Pérez-Martínez et al. (2008); España y Latinoamérica.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento y Autonomía. Competencia funcional comunitaria e instrumental.
Tipo de Instrumento	Heteroinforme / juicio clínico de 8 ítems conductuales aplicado al paciente o cuidador.
Población y Rango	Adultos mayores comunitarios o institucionalizados; sospecha de deterioro cognitivo.
Tiempo de Administración	5 a 10 minutos de administración semiestructurada.
Régimen de Licencia	Dominio público internacional / Acceso abierto sin restricciones comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LAS ACTIVIDADES INSTRUMENTALES

La **Escala de Lawton y Brody** evalúa las **Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)**, definidas como aquellas conductas complejas de interacción comunitaria necesarias para vivir de manera independiente en el propio domicilio:

- Jerarquía Funcional y Sensibilidad Cognitiva:** Las AIVD exigen un nivel de integración neuropsicológica, funciones ejecutivas (planificación, secuenciación, memoria de trabajo) y praxias mucho más elevado que las actividades básicas de autocuidado (Barthel).
- Marcador Precoz de Transición a la Demencia:** En la historia natural del deterioro neurocognitivo, las AIVD son las primeras en deteriorarse, permitiendo discriminar con altísima especificidad entre el Envejecimiento Normal, el **Deterioro Cognitivo Leve (DCL)** (donde las AIVD se conservan o presentan solo mínima dificultad) y la **Demencia Establecida** (donde las AIVD se pierden de forma invalidante).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (8 ACTIVIDADES INSTRUMENTALES)

Actividad Instrumental	Puntuación	Criterios Operativos de Calificación (1 = Independiente / 0 = Dependiente)
1. Uso del Teléfono	0 o 1 pto	1 = Utiliza el teléfono por iniciativa propia, busca y marca números; 0 = No es capaz de marcar.
2. Ir de Compras	0 o 1 pto	1 = Realiza independientemente todas las compras necesarias; 0 = Necesita ser acompañado.
3. Preparación de Comida	0 o 1 pto	1 = Planifica, prepara y sirve comidas adecuadas solo; 0 = Necesita que se la preparen.
4. Cuidado de la Casa	0 o 1 pto	1 = Realiza tareas domésticas pesadas o ligeras; 0 = No participa o necesita ayuda constante.
5. Lavado de Ropa	0 o 1 pto	1 = Lava y plancha toda su ropa o pequeñas prendas solo; 0 = Incapaz de lavar ropa.
6. Uso de Transporte	0 o 1 pto	1 = Viaja solo en transporte público o taxi; 0 = No viaja o solo con acompañante.
7. Manejo de Medicación	0 o 1 pto	1 = Toma su medicación correctamente en dosis y horarios; 0 = Necesita supervisión.
8. Manejo del Dinero	0 o 1 pto	1 = Maneja asuntos económicos, firma cheques y controla gastos; 0 = Incapaz de contar dinero.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones geriátricas españolas (Cid-Ruzafa & Damián-Moreno, 1997; Pérez-Martínez et al., 2008) confirman su robustez métrica:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Confiabilidad Interjueces	CCI $r = 0.85 - 0.94$	Excelente concordancia entre evaluadores profesionales y cuidadores primarios.
Consistencia Interna	Alfa $\alpha = 0.89 - 0.93$	Elevada homogeneidad en la escala completa de 8 reactivos instrumentales.
Estabilidad Temporal	Test-retest $r = 0.90$	Alta reproducibilidad en reevaluaciones a corto plazo en adultos mayores estables.
Sensibilidad Diagnóstica	Sensibilidad = 0.88 (Demencia)	Excelente capacidad para discriminar demencia inicial (corte < 5 en mujeres, < 4 en varones).
Validez Convergente	$r = 0.72$ (MEC de Lobo)	Fuerte correlación con escalas de cribado neurocognitivo y pruebas ejecutivas (Trail Making).

5. REGLAS DE APLICACIÓN, CÓMPUTO Y CORRECCIÓN DE SESGO DE GÉNERO

- **Puntuación Dicotómica:** Cada ítem se califica como **1 punto (independiente)** o **0 puntos (dependiente o necesita ayuda)**.
- **Superación del Sesgo de Género Histórico:** En la versión original de 1969, se excluían las tareas domésticas (cocina, limpieza, lavado) en varones, evaluándolos sobre 5 puntos y a las mujeres sobre 8. En la práctica clínica contemporánea validada en España:
 1. Si el varón ha realizado habitualmente dichas tareas a lo largo de su vida, se evalúan los **8 reactivos completos**.
 2. Si nunca las realizó por asignación cultural de roles previa al deterioro, esos ítems se **excluyen del cómputo** y se ajusta proporcionalmente la puntuación sobre los ítems aplicables:

$$\text{Puntuación Ajustada} = \left(\frac{\text{Puntos Obtenidos}}{\text{Número de Ítems Aplicables}} \right) \times 8$$

- **Puntuación Total:** Rango continuo de **0 a 8 puntos**.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN DE DEPENDENCIA

Estratificación	Puntuación	Grado de Autonomía	Significación Clínica y Pronóstico Sociosanitario
Independencia Total	8 pts	Autonomía comunitaria plena	Capacidad intacta para vivir solo y gestionar su propio hogar y finanzas.
Dependencia Ligera	6 a 7 pts	Deterioro instrumental incipiente	Dificultades aisladas en tareas complejas (finanzas o transporte); sospecha DCL.
Dependencia Moderada	4 a 5 pts	Disfunción instrumental manifiesta	Incapacidad para cocinar o tomar medicación solo; requiere supervisión diaria.
Dependencia Severa	2 a 3 pts	Dependencia avanzada	Pérdida de casi todas las actividades comunitarias; claudicación domiciliar.
Dependencia Total	0 a 1 pto	Dependencia instrumental absoluta	Incapacidad total para cualquier interacción instrumental comunitaria.

SIGNIFICACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA CAÍDA EN DINERO Y MEDICACIÓN (ÍTEMS 7 Y 8):

El fallo en el manejo autónomo del dinero (ítem 8) o de la medicación (ítem 7) en un adulto mayor con puntuación intacta en Barthel (100/100) es el marcador psicopatológico más precoz de **conversión de Deterioro Cognitivo Leve a Enfermedad de Alzheimer**.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN NEUROCOGNITIVA Y PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GERIÁTRICA BASADO EN LA ESCALA DE LAWTON:

- **Paso 1 (Cribado Preventivo Anual):** Administrar en atención primaria a todo adulto mayor de 70 años que viva solo.
- **Paso 2 (Actuación ante Pérdida de 1-2 Puntos [6-7 pts]):** Realizar valoración neuropsicológica formal exhaustiva (MoCA / Test del Reloj); no atribuir el fallo al "envejecimiento normal".
- **Paso 3 (Protección Jurídica y Sanitaria en Caídas < 5 Pts):**
 - Retirar la custodia de talonarios bancarios y tarjetas de crédito para prevenir estafas telefónicas o desfalcos.
 - Pautar la administración de fármacos en pastillero semanal supervisado por familiar o enfermería.
- **Paso 4 (Tramitación de Recursos Asistenciales):** Puntuaciones ≤ 4 justifican el inicio urgente del expediente de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DETECCIÓN PRECOZ DE DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

Identificación: Mujer de 75 años, viuda, residente sola en su domicilio. Su hijo consulta preocupado tras descubrir que su madre fue víctima de una estafa comercial domiciliar de 2.000 euros y observar que la comida del frigorífico estaba caducada, aunque ella insiste en que "se encuentra perfectamente y no necesita a nadie".

Evaluación Psicométrica Inicial:

- **Índice de Barthel = 100 / 100 puntos (Independencia Total en ABVD:** se asea, come, camina y se viste sola).
- **Escala de Lawton y Brody = 4 / 8 puntos (Dependencia Moderada en AIVD):**
 - *Uso del teléfono:* 1/1 (Responde y marca números conocidos).
 - *Compras:* 0/1 (Compra productos repetidos o innecesarios; olvida lo básico).
 - *Comida:* 0/1 (Olvida sartenes al fuego; consume alimentos en mal estado).
 - *Cuidado de la casa:* 1/1; *Lavado de ropa:* 1/1.
 - *Transporte:* 0/1 (Se desorientó en dos ocasiones en la línea de autobús habitual).
 - *Medicación:* 0/1 (Doble toma de antihipertensivos con mareos ortostáticos secundarios).
 - *Dinero:* 0/1 (Incapaz de cotejar cambios monetarios y vulnerable a manipulación comercial).

Diagnóstico e Intervención: Se confirmó Enfermedad de Alzheimer en estadio leve-moderado (GDS 4). Se tramitó servicio de teleasistencia, comidas a domicilio y supervisión familiar estricta de cuentas bancarias y fármacos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RIESGO INMEDIATO DE INTOXICACIÓN:

Una puntuación de 0 en el ítem de medicación en un anciano pluripatológico anticoagulado o diabético es una emergencia preventiva que exige intervención familiar en menos de 24 horas.

SESGO CULTURAL DE ROL PREVIO:

Verificar siempre si la incapacidad en cocina o lavado es un déficit adquirido por demencia o la continuación de un estilo de vida donde el cónyuge asumía históricamente esas tareas.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Lawton, M. P., & Brody, E. M. (1969). Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living. *The Gerontologist*, 9(3), 179-186.
2. Cid-Ruzafa, J., & Damián-Moreno, J. (1997). Valoración de la discapacidad física: El índice de Barthel y la escala de Lawton. *Revista Española de Salud Pública*, 71(2), 127-137.
3. Pérez-Martínez, D. A., et al. (2008). Validación y baremación de la escala de actividades de la vida diaria de Lawton y Brody en una muestra comunitaria de adultos mayores en España. *Neurología*, 23(7), 421-429.
4. Vergara, I., et al. (2012). Validation of the Lawton IADL scale in a Spanish population of elderly people. *BMC Health Services Research*, 12, 147.